

間歇性自我導尿 (ISC)

病人須知 · 用細尿管自己排空膀胱

WARWIKI

間歇性自我導尿 (ISC) 係你自己輕輕將一條細軟尿管插入膀胱、排走尿液、然後拔出 — 每日做幾次。當膀胱唔能夠自行排空嘅時候就需要用呢個方法。學識咗之後只需幾分鐘，可以令你更自由，同時保護腎臟。

點解要做

如果膀胱唔能夠完全排空 — 例如某些手術後、有**神經源性膀胱**、脫垂或出口阻塞 — 殘餘尿液可引致感染、漏尿，以及對腎臟造成傷害。ISC 按時程**完全排空膀胱**，解決上述問題。

點解 ISC 優於留置尿管

- **感染機會較少**，比留置（長期放住）尿管好
- **唔使帶尿袋**，導尿之間行動更自由
- 長遠對膀胱同腎臟有更好嘅保護

一開始可能覺得困難，但大多數人 — 包括照顧者 — 在護士指導下都能夠快速學識。

詞彙解釋

ISC

間歇性自我導尿 — 自己排空膀胱後拔出尿管。

尿管

插入膀胱排出尿液嘅細軟管。

導尿後殘餘尿量

排尿後膀胱內剩下嘅尿量。

神經源性膀胱

因神經問題令膀胱功能異常。

清潔技術

洗手及清潔局部位置 — 清潔即可，唔需要完全無菌。

留置尿管

長期放住並連接尿袋嘅尿管（ISC 可幫你避免用呢種方法）。

會唔會痛？ 通常唔痛 — 大多數人只感到輕微壓力，而現代尿管已預先塗上潤滑劑且非常幼細。頭幾次可能有輕微不適或少量血跡。護士會一步一步教你，直至你有信心自己做到為止。

點樣做（清潔技術）

- 1 **洗手**，準備好用品；清潔尿道口。
- 2 **輕輕插入**已潤滑嘅尿管，直至有尿液流出；再稍微推入少少。
- 3 讓膀胱**完全排空**，然後慢慢拔出尿管。
- 4 棄置一次性尿管（或按指示清潔可重用尿管），然後洗手。

導尿頻率

- 通常**每 4-6 小時**一次（每日約 4-6 次）— 具體時程由醫療團隊訂定。
- 唔好跳過 — 定時導尿可防止膀胱過脹及感染。
- 照常飲水；如有要求請記錄尿量。

實用須知

- 喺任何清潔廁所都可以做；用品細巧方便攜帶。
- 輕微混濁或有細菌屬正常 — 只有出現**症狀**時先需要治療 UTI。
- 如果你自己唔方便做，可以教照顧者代勞。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- **插唔入尿管**，或感覺膀胱脹但排出尿量極少
- 發燒、畏寒或腰背痛（可能係感染）
- 持續**出血**或明顯痛楚

要記住嘅三件事

1. ISC 幫助唔能夠自行排空嘅膀胱完全排尿 — 保護腎臟，預防感染同漏尿。
2. 用清潔技術按定時時程導尿（通常每 4-6 小時）；護士會教你直至輕鬆掌握為止。
3. 通常唔痛，亦比留置尿管安全。如插唔入、排唔到尿或發燒，請聯絡醫療團隊。